

10. BILDUNG DES OBEREN DARMS

DAUER : 25:32

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung des oberen Darms und beleuchtet die komplexen Bewegungen des Endoderms und die vaskulären Interaktionen. Sie erfahren, wie sich diese embryologischen Prozesse in der Bildung der Kiemenbögen und der Organisation der Gesichtsstrukturen niederschlagen und wie dieses Wissen in einem therapeutischen Kontext angewendet werden kann. Die Konzepte der embryonalen Flexion, der Zerebralisation und der Auswirkungen der Osteopathie auf die Dynamik der Kieferbögen und der Zahnstrukturen werden behandelt und bieten praktische Werkzeuge zur Wiederherstellung der Harmonie der inneren Architektur.

BILDUNG DES OBEREN DARMS

Die Bildung des oberen Darms ist ein komplexer Prozess, der die Bewegung des **Entoderms** beinhaltet. Diese Bewegung manifestiert sich sowohl in ihrer Gesamtheit als auch **transversal**, wodurch ein Sack in einen Schlauch umgewandelt wird. Die **Amnionhöhle** spielt eine Schlüsselrolle bei dieser Bewegung, indem sie den Embryo vollständig umschließt und den Verdauungstrakt von außen nach innen integriert, hauptsächlich gesteuert durch das primitive **Aortenband**.

Konzentriert man sich auf die **vaskuläre** Ebene, so beobachtet man, dass sich die primitiven Endokardschläuche gleichzeitig mit dem Verschluss des Neuralrohrs annähern. Diese Begegnung schafft einen Raum im Lumen des **primitiven Dottersack-Entoderms**, wodurch der sogenannte **Pharynx-Darm** entsteht. Dieser Prozess findet in der Mittellinie statt, während lateral die **Zellulose** erscheint.

Das differentielle Wachstum des **Epithelgewebes** im Vergleich zum **Bindegewebe** ermöglicht die Annäherung der beiden Aorten an die zentrale Achse, wodurch die Längsachse abgegrenzt und der Pharynx-Darm gebildet wird. Der obere Darm erstreckt sich vom Mund bis zum mittleren Teil und beinhaltet die Bildung des Gesichts.

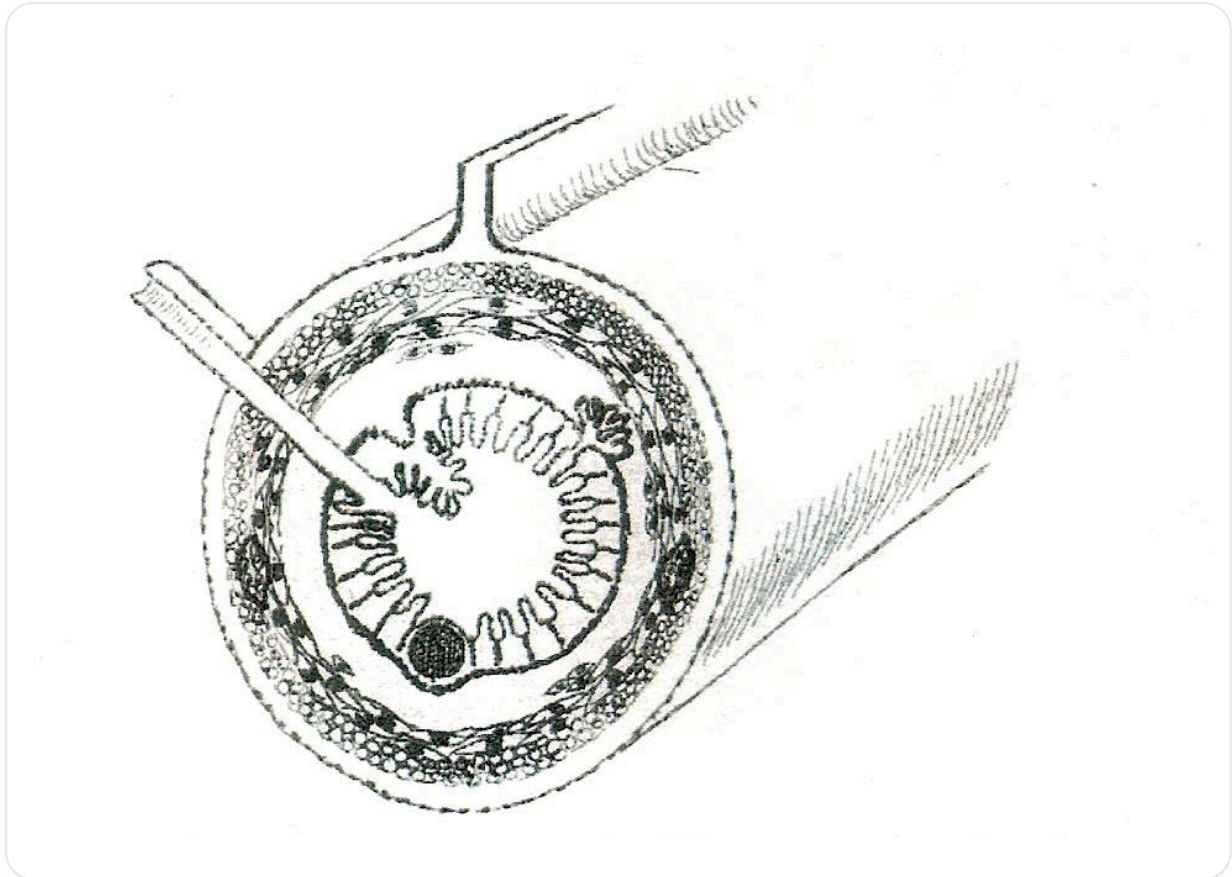


ABB. — Querschnitt Darm

Nach etwa fünfzehn Tagen, am Ende der zweiten Woche, kann der Embryo in drei Teile unterteilt werden: das **obere Drittel**, das **mittlere Drittel** und das **untere Drittel**. Der Kopf des zukünftigen Embryos ist im Verhältnis zu einem kleinen Rumpf unverhältnismäßig groß, wobei der kraniale Teil bereits identifizierbar ist. Die Hälfte des Embryos befindet sich an der Schädelbasis, in Beziehung zum **Chorda-Feld** im Verhältnis zur Primitivrinne.

Die Beugung des Embryos wird durch das Gefäßsystem beeinflusst. Ein einfaches Schema zeigt, dass sich ein Rohr biegt, wobei ein Bereich verdichtet und ein anderer gedehnt wird, wodurch **Falten** entstehen. Innen ist das Gewebe **entodermisch**, während es außen **ektodermisch** ist, mit einem **mesodermischen** Gewebe dazwischen. Die Kiemenbögen, die im Raum in Bezug auf den Embryo organisiert sind, enthalten spezifische Informationen.

Jeder Kiemenbogen ist auf die Schädelbasis ausgerichtet. Die Mandibularbögen beispielsweise treffen sich in Richtung dieser Basis. Die Behandlung eines Gesichts oder Schädels beinhaltet die Wiederherstellung dieser primitiven Funktion, indem ein **Energiefeld** wiederhergestellt wird, das sich in diesem Raum organisiert.

Man kann vier große funktionelle Kiemenbögen identifizieren: den **Mandibularbogen**, den **Hyoidbogen**, den **oberen Larynxbogen** und den **unteren Larynxbogen**. Jeder Bogen, ob ektodermisch, mesodermisch oder entodermisch, enthält spezifische Informationen. Der Mandibularbogen ist beispielsweise mit dem Mandibularknorpel und Strukturen des **Innenohrs** verbunden. Eine Destabilisierung des Kiefers kann daher die innere Organisation des Ohrs beeinflussen.

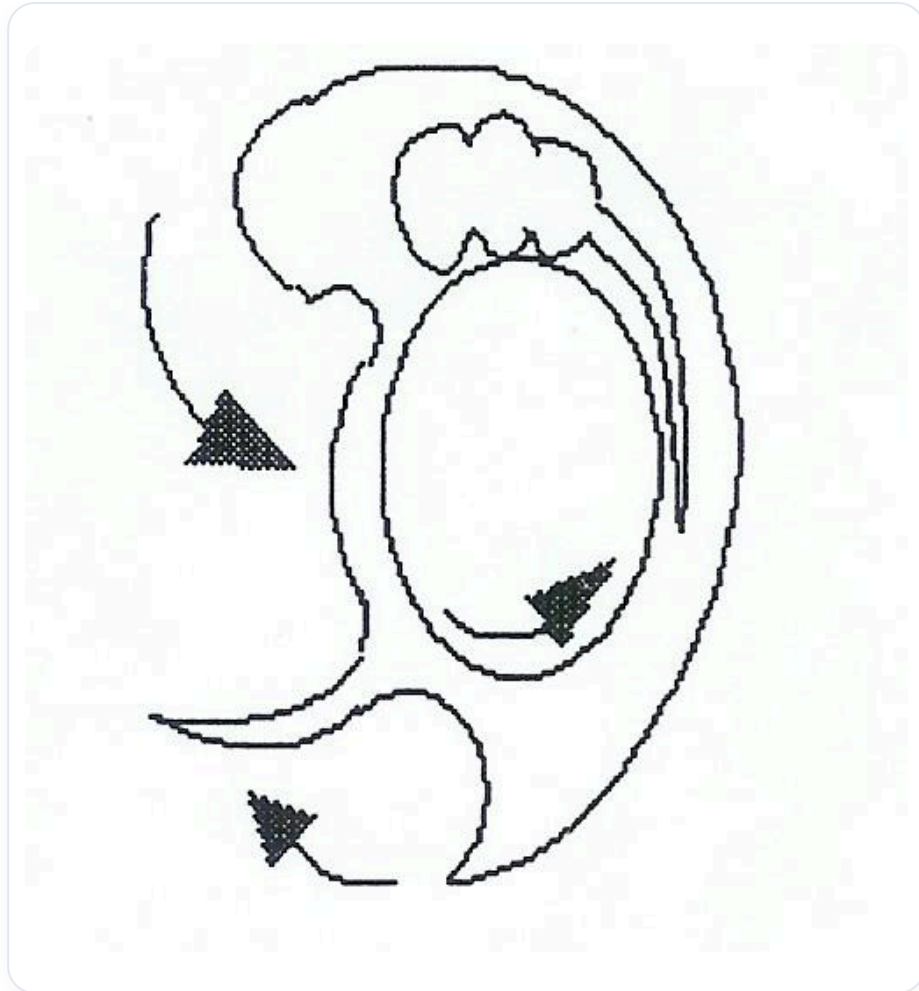


ABB. — Embryonales Innenohr

Der Prozess der Beugung und Streckung des Embryos hängt auch mit der **Zerebralisation** und der Bildung des **Prosencephalon-Systems** zusammen. Diese Entwicklung erfolgt in einem **biodynamischen** Prozess, bei dem sich der Embryo zu beugen und zu öffnen beginnt. Das Herz entwickelt sich zwischen dem Mental, dem Neuralrohr und der Leber und bildet so das Gesicht.

Der Bruch der **Bukkopharyngealmembran** markiert den Beginn der Mundbildung, die sich aufgrund der Kompression zwischen Herz und Gehirn horizontal entwickelt. Diese Kompression integriert das mesodermische Gewebe, das die vaskuläre Information enthält. Das Auftreten der **Nasengrube** und der Mundhöhle hängt ebenfalls mit dieser Dynamik zusammen.

Die Entwicklung des Gehirns steht in Beziehung zum Prozess der **Telencephalisation**, der einen Aufstieg des Gehirns und einen viszerale Abstieg beinhaltet. Das Gesicht ist zunächst ein Kompressionsfeld zwischen Herz und Gehirn und öffnet sich durch das Wachstum des Embryos.

Die Entwicklung der **Pterygoide** und des **Gaumens** wird durch den Zug des Gehirns und den viszerale Abstieg beeinflusst. Diese synchronisierte Bewegung zwischen Verdauungssystem und Herz sowie der zerebrale Aufstieg tragen zur Bildung des gotischen Gaumens bei.

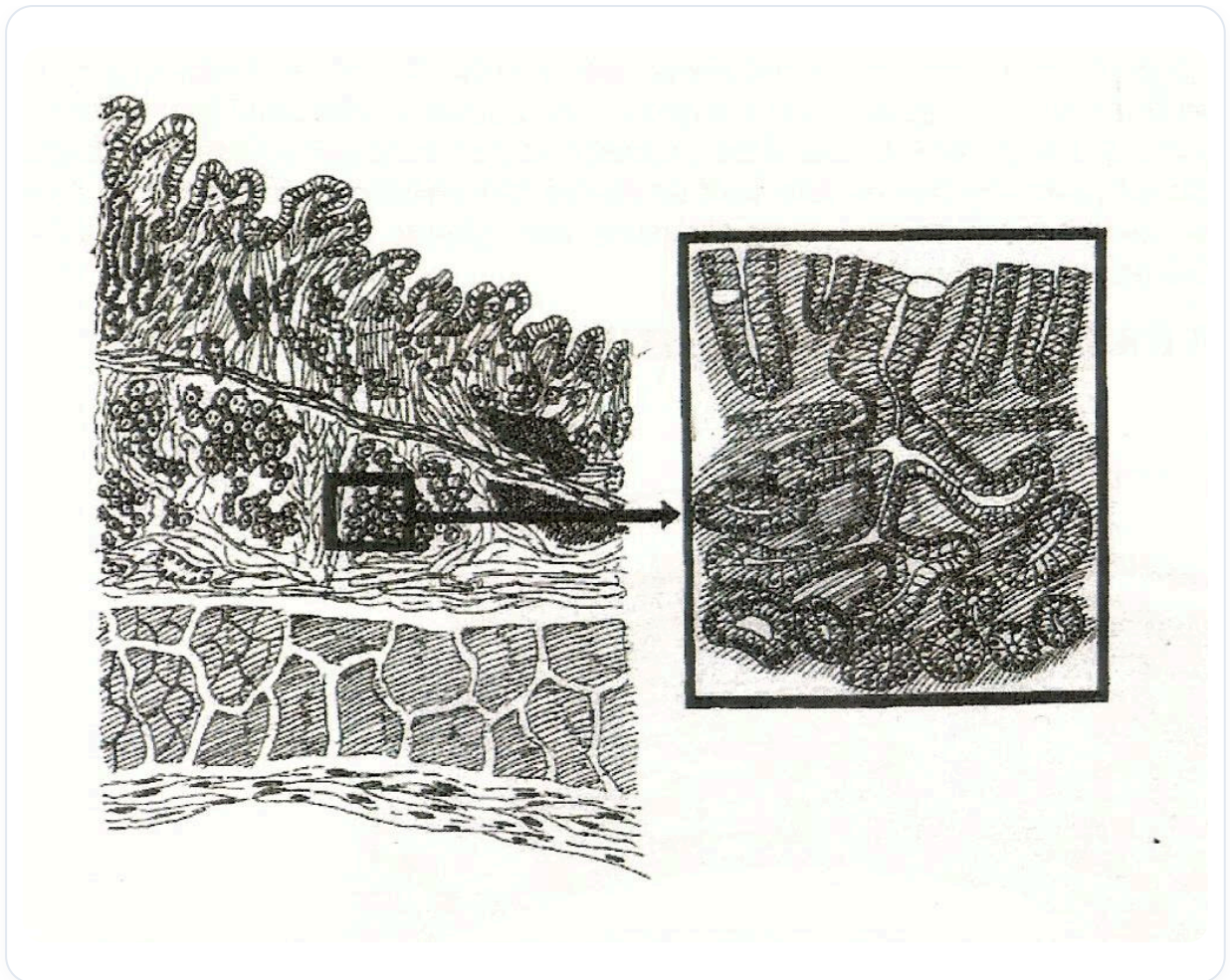


ABB. — Darmgewebe Zotten

Die okklusalen Kräfte, die Drücke des Zungenmassivs und die piezoelektrischen Effekte beeinflussen ebenfalls die Bildung der Zähne und der Gesichtsstrukturen. Jeder Zahn erhält spezifische Informationen, und die Behandlung des Gesichts oder der Zähne erfordert ein Wiederherstellen des Gleichgewichts dieser Strukturen mit ihrem embryonalen Ursprung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bildung des oberen Darms und der Gesichtsstrukturen ein komplexer Prozess ist, der dynamische Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen embryonalen Geweben und deren synchronisierte Entwicklung beinhaltet.

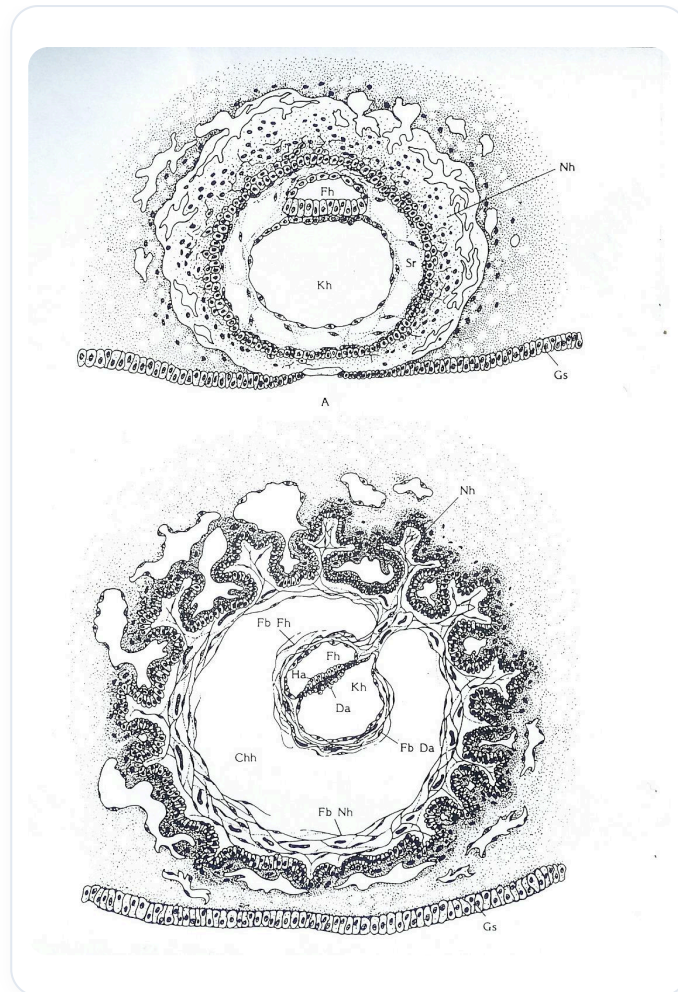
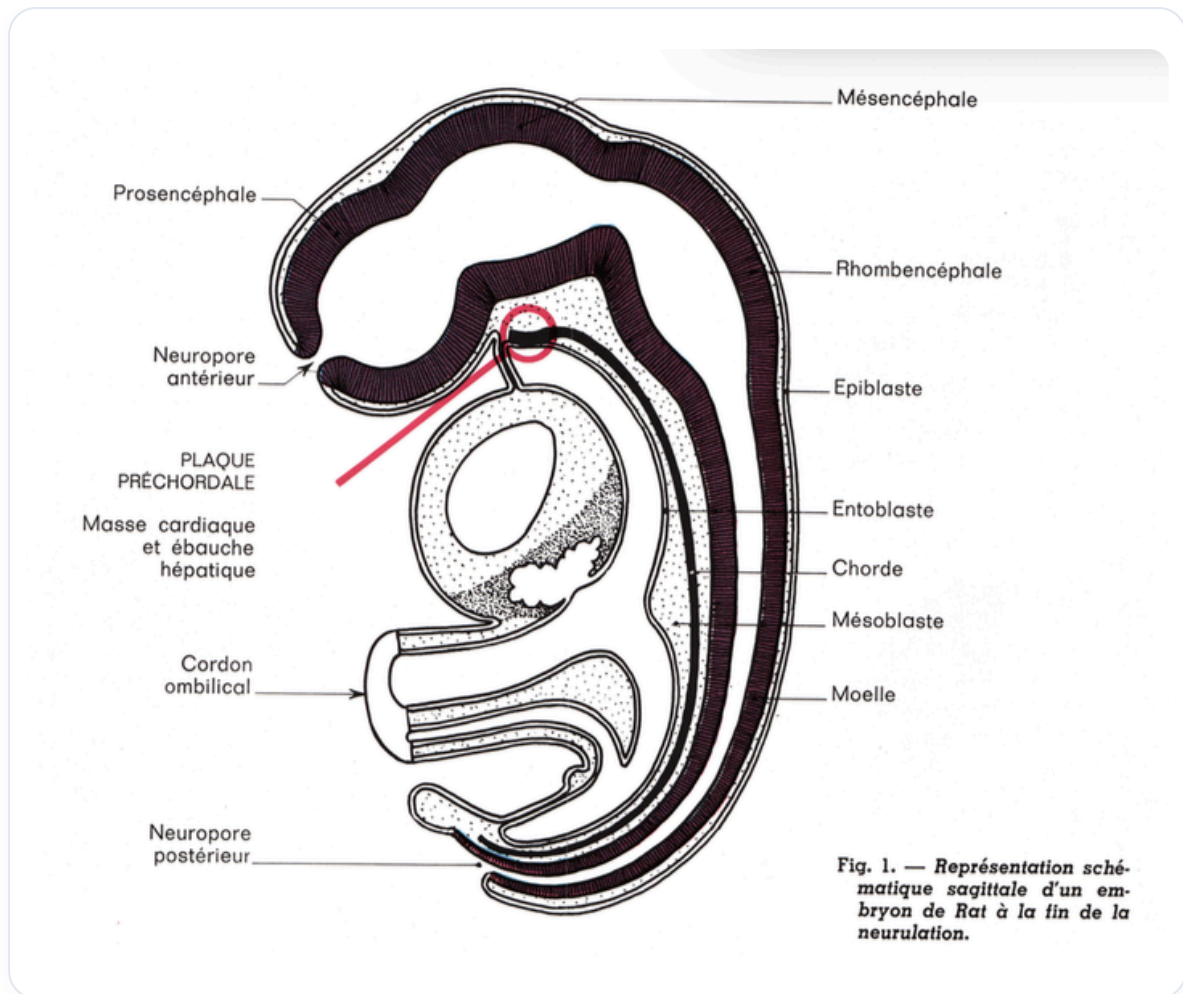


ABB. — Vogel-Embryonalentwicklung



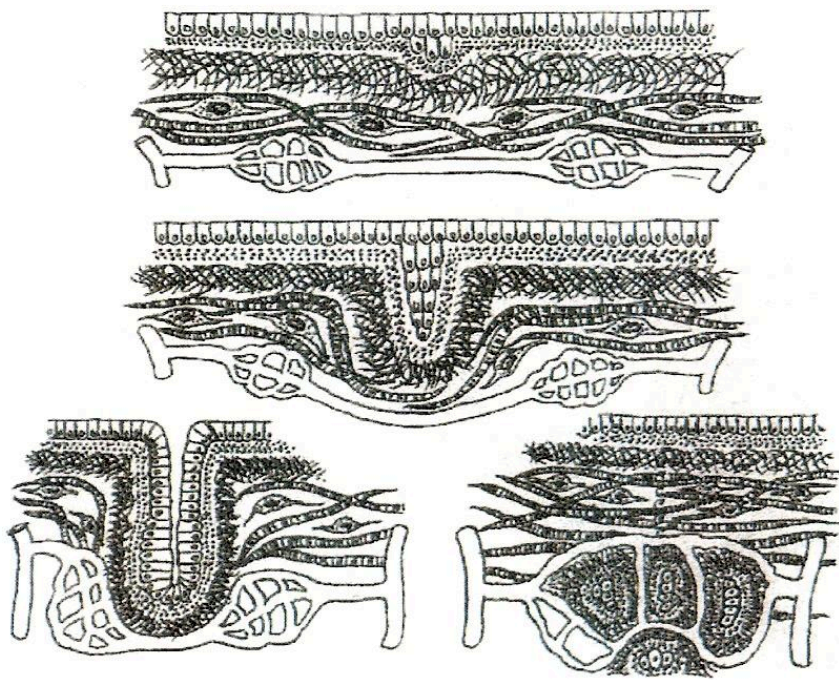


ABB. — Darmvillifizierung